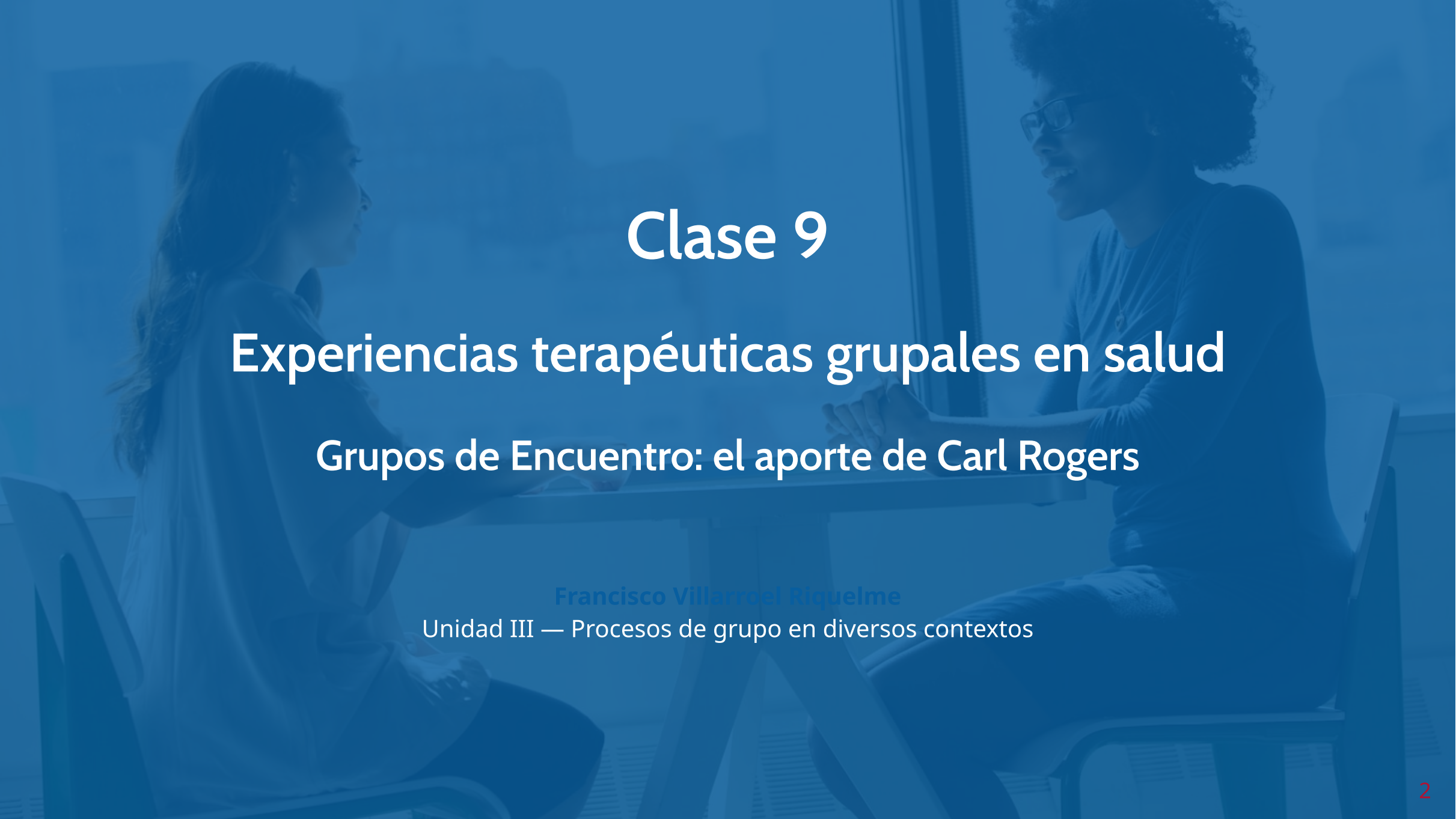


A background image showing two women sitting at a table, engaged in a conversation. The woman on the left is seen from the side, and the woman on the right is facing her. They are in a bright, modern setting with large windows in the background. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

Clase 9

Experiencias terapéuticas grupales en salud

Grupos de Encuentro: el aporte de Carl Rogers

Francisco Villarroel Riquelme

Unidad III — Procesos de grupo en diversos contextos

Estructura de la clase

BLOQUE 1 — 70 min

- Terapia grupal en el contexto de salud (10 min)
- Por que el contexto institucional importa (10 min)
- Carl Rogers: fundamentos filosoficos y teoricos (20 min)
- Las tres actitudes terapeuticas (15 min)
- Video 1 + discusion guiada (15 min)

BLOQUE 2 — 70 min

- Grupos de encuentro: definicion y proceso (20 min)
- Rol del facilitador rogeriano (10 min)
- Valor, limitaciones y debates actuales (15 min)
- Video 2: dialogo Rogers-Katy (10 min)
- Actividad en pares + plenaria (15 min)

Competencias: Distinguir fenomenos grupales relevantes para el funcionamiento psicosocial (3.2) y aplicar constructos teoricos para explicar procesos grupales en casos reales o simulados (3.3)

BLOQUE 1

La terapia grupal en salud y los fundamentos de Rogers

La terapia grupal en el sistema de salud

En el mundo

- Pratt (1905): primeros grupos con enfermos de tuberculosis en Boston. Descubre el poder del apoyo entre pares casi accidentalmente
- Expansion masiva post-Segunda Guerra Mundial ante demanda desbordada
- Hoy: modalidad clinicamente justificada con mecanismos de cambio propios

En Chile

- Grupos terapeuticos en COSAM, hospitales de dia y APS
- Plan Nacional de Salud Mental (2017–2025) promueve modalidades grupales en APS
- Creciente interes en modelos de pares, grupos de apoyo en enfermedades cronicas y grupos post-hospitalizacion

El grupo no es un recurso de segunda categoria ante la escasez de profesionales: es una **modalidad clinicamente justificada** con mecanismos de cambio propios que la terapia individual no puede replicar (Yalom & Leszcz, 2005).

¿Por que el contexto institucional importa?

Una pregunta de encuadre antes de entrar a Rogers:

¿En que se diferencia hacer terapia grupal en un **hospital psiquiatrico** vs. en un **COSAM comunitario** vs. en un **centro comunitario gestionado por la propia comunidad**? ¿Cambia el objetivo? ¿El tipo de grupo? ¿Los mecanismos de cambio?

La respuesta es: si, en muchos aspectos. El contexto determina:

- **Poblacion:** nivel de cronicidad, diagnosticos prevalentes, vulnerabilidad social
- **Encuadre posible:** grupos abiertos o cerrados, frecuencia, duracion total
- **Objetivos realistas:** desde estabilizacion sintomatica hasta transformacion relacional profunda
- **Rol del facilitador:** mas directivo en crisis; mas exploratorio en grupos de desarrollo

Esta tension *contexto / modalidad* sera un hilo conductor de las proximas cuatro clases.

Carl Rogers: quien era y por que importa

Trayectoria intelectual

- Formacion inicial en teologia, luego psicologia clinica
- Trabajo temprano con ninos en situacion de pobreza: genera desconfianza del diagnostico y la autoridad experta
- Enfoque no-directivo (1942) → centrado en el cliente (1951) → centrado en la persona (1961)
- Ultima etapa: aplicacion a grupos, educacion y resolucion de conflictos internacionales

La ruptura historica

- En su epoca dominaban el psicoanalisis (terapeuta como interprete experto) y el conductismo (terapeuta como modificador de conducta)
- Rogers propone algo distinto: **el cambio no viene del terapeuta sino de la propia persona**, si se le ofrecen las condiciones relacionales adecuadas
- Implicacion para el grupo: si el cambio viene de la relacion, entonces el grupo **multiplica las posibilidades de cambio**

Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy*. Houghton Mifflin. / Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person*. Houghton Mifflin.

La vision de la persona en Rogers

Todo ser humano posee una **tendencia actualizante**: una motivacion inherente, biologica y psicologica, hacia el crecimiento, la autonomia y el desarrollo de sus potencialidades. Esta tendencia no desaparece con el sufrimiento: puede quedar bloqueada, pero siempre esta presente.

Tres conceptos teoricos clave:

El self

Estructura cognitivo-afectiva que organiza la experiencia. Como me veo, como creo que me ven, como quisiera ser. Es una construccion, no una esencia fija.

Incongruencia

Tension entre la experiencia organismica (lo que siento/vivo) y el self (lo que "deberia" sentir segun mis condiciones de valor aprendidas). Fuente del malestar psicologico.

Condiciones de valor

Aprendemos que somos aceptados si somos de cierta manera. Estas condiciones se internalizan y distorsionan la percepcion de la propia experiencia.

Las tres actitudes terapéuticas nucleares

Rogers (1957) propone que el cambio terapéutico depende de **condiciones relacionales** que el terapeuta debe encarnar, no de técnicas aplicadas:

1. Congruencia

(Autenticidad)

El/la terapeuta es genuino/a: lo que siente, piensa y expresa es coherente. No hay máscara profesional. Rogers la considera la condición más fundamental: sin ella, las otras dos son falsas.

2. Consideración positiva incondicional

(Aceptación)

Aceptación cálida y sin juicio del cliente como persona, independientemente de lo que revele. No significa aprobar todo: significa que el valor de la persona no está en cuestión.

3. Comprensión empática

(Empatía)

Entrar en el mundo interno del cliente "como si" fuera el propio, sin perder el "como si". No es simpatía: es comprensión activa del significado personal de la experiencia del otro.

Rogers (1957) propone que estas condiciones son **necesarias y suficientes** para el cambio terapéutico — una de las tesis más debatidas de la historia de la psicoterapia.

Debate: ¿condiciones necesarias y suficientes?

La investigación posterior matiza la tesis de Rogers. Lambert & Barley (2001) estiman que la **alianza terapeutica** — fuertemente relacionada con las condiciones rogerianas — explica ~30% de la varianza en resultados. Pero para trastornos específicos (TOC, fobia, TEPT), las técnicas específicas muestran eficacia diferencial que no puede atribuirse solo a la relación.

Lo que la evidencia sostiene

- La empatía percibida es un predictor robusto del resultado terapéutico
- La alianza terapéutica es el factor común más importante entre enfoques
- La consideración positiva incondicional reduce la vergüenza y facilita la autorrevelación

Lo que la evidencia matiza

- Las condiciones son probablemente necesarias pero no suficientes para todos los problemas
- La no-directividad puede ser inadecuada en crisis aguda, psicosis activa o trauma complejo
- La "autenticidad" del terapeuta debe calibrarse: no toda emoción propia debe expresarse

VIDEO 1 — Actitudes terapeuticas en el ECP

 **Video: "Carl Rogers — Las actitudes terapeuticas en el Enfoque Centrado en la Persona"**

<https://www.youtube.com/watch?v=YCVCJNCQgxk>

Mientras ven, anoten individualmente:

1. ¿Como describe Rogers cada actitud con sus propias palabras? ¿Que ejemplos da?
2. ¿Hay tension o ambigüedad en algun punto de su descripcion?
3. ¿Que implicancias tendrian estas actitudes si el "terapeuta" es un **grupo de personas** y no un individuo?

Discusion en plenaria (10 min):

- ¿Cual de las tres actitudes les parece mas dificil de encarnar genuinamente?
- ¿Pueden pensar en situaciones donde la consideracion positiva incondicional sea especialmente dificil?

BLOQUE 2

Grupos de Encuentro: definición, proceso y debate

Del ECP al grupo: itinerario historico

1947 Kurt Lewin funda el NTL Institute y los primeros T-groups. Rogers los conoce y dialoga con esa tradicion. **1950s** En la Universidad de Chicago, Rogers y sus estudiantes desarrollan grupos no-directivos en contextos educativos. **1962-64** El movimiento del potencial humano (Esalen Institute, California) adopta y radicaliza el formato grupal. Rogers participa activamente. **1970** Publica *Carl Rogers on Encounter Groups*: sistematizacion teorica de su experiencia grupal. **1970s-80s** Aplica los grupos de encuentro a educacion, relaciones interraciales y procesos de paz internacionales.

Los grupos de Chicago se orientaron, sobre todo, hacia el desarrollo personal y el aumento y mejoramiento de la comunicación y las relaciones interpersonales, en vez de considerar que éstas eran finalidades secundarias. Además, tuvieron una orientación más experiencial y terapéutica que los grupos nacidos en Bethel. Con el correr de los años, esta orientación hacia el desarrollo personal y terapéutico se fusionó con la correspondiente a la formación en relaciones humanas, y la combinación de ambos caminos constituye lo esencial de la tendencia que se difunde hoy en los Estados Unidos con tanta rapidez (Carlo Rogers, 1970)

Los Grupos de Encuentro: definicion

Un **grupo de encuentro** (*encounter group*) es un grupo pequeno e intensivo, de duracion limitada, cuyo objetivo es facilitar el **crecimiento personal** y la mejora de la **comunicacion interpersonal** a traves de la expresion autentica de experiencias, sentimientos y percepciones en el aqui-y-ahora del grupo (Rogers, 1970).

Dimension	Descripcion
Tamano	8 a 18 personas
Duracion	Fin de semana intensivo hasta varias semanas
Facilitador/a	No directivo/a; crea clima, no dirige contenido
Objetivo	Crecimiento personal, no tratamiento clinico
Foco	Experiencia presente del grupo (aqui-y-ahora)
Seleccion	Poblacion general, no necesariamente clinica

El proceso del grupo de encuentro

Rogers (1970) describe una secuencia observable aunque no lineal ni universal:

Fases iniciales

1. *Dando vueltas en círculos: (fase de rodeo)* confusión, resistencia, conversación superficial
2. *Resistencia a la expresión personal:* ¿es seguro ser auténtico aquí?
3. *Descripción de sentimientos del pasado:* primeras aperturas referidas a "allá y entonces"
4. *Expresión de sentimientos negativos en el aquí-y-ahora:* primer gran riesgo; prueba de la seguridad del espacio

Fases de profundización

1. *Expresión de material significativo y doloroso:* el grupo gana confianza para lo vulnerable
2. *Sentimientos interpersonales inmediatos:* retroalimentación directa entre miembros
3. *Capacidad curativa del grupo:* los miembros comienzan a responder terapéuticamente a otros
4. *Auto-aceptación e inicio del cambio:* ser visto y aceptado moviliza transformación interna

Fases finales

9. *Resquebrajamiento de las fachadas:*
 1. *El individuo recibe realimentación/enfrentamiento:*
 2. *Enfrentamiento*
 3. *La relación asistencial fuera de las sesiones del grupo*
 4. *El encuentro básico*
 5. *Expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo*
 6. *Cambios de conducta*

Debido a la naturaleza no estructurada del grupo, el problema principal de los participantes es cómo utilizar juntos su tiempo, ya se trate de dieciocho horas de un fin de semana o de cuarenta o más horas en un grupo semanal. Al principio, existe con frecuencia un estado de consternación, ansiedad e irritación, que obedece sobre todo a la falta de estructura. Sólo en forma gradual se pone de manifiesto que la finalidad más importante de casi todos los miembros es hallar maneras de relacionarse con otros integrantes del grupo y consigo mismos. Luego, al explorar paulatina, tentativa y temerosamente sus sentimientos y actitudes recíprocos y hacia sí mismos, cada vez les resulta más claro que lo primero que manifestaron eran fachadas, máscaras. (Carl Roger, 1970)

El rol del facilitador rogeriano

El facilitador rogeriano no es un líder directivo ni un experto: es una **presencia facilitadora** que crea las condiciones para que el grupo encuentre su propio camino.

Lo que el facilitador hace

- Expresa sus propias reacciones cuando son relevantes para el proceso (congruencia grupal)
- Recibe y acepta las expresiones de los miembros sin juzgar ni interpretar
- Refleja el proceso grupal: "Noto que el grupo se puso más silencioso cuando..."
- Confía en la capacidad del grupo para autogestionarse
- Interviene para proteger a un miembro si el grupo se vuelve persecutorio

Lo que el facilitador NO hace

- No impone agenda temática
- No interpreta el "inconsciente" del grupo (cf. Bion)
- No enseña ni da consejos expertos
- No fuerza la expresión emocional
- No sostiene una "neutralidad" artificial que encubra una posición de poder

Aplicaciones mas alla de la clinica

Rogers llevo el grupo de encuentro a contextos no clinicos con resultados variables pero notables:

Educacion

Grupos de encuentro entre docentes y estudiantes para transformar la relacion pedagogica. Influye en la "educacion centrada en el estudiante".

Relaciones interculturales

En los anos 70, Rogers facilita grupos entre comunidades con conflicto racial en EE.UU., y hacia el final de su vida en Irlanda del Norte y Sudafrica.

Organizaciones

Grupos de encuentro en empresas para mejorar la comunicacion interna y el clima. Precursor del Desarrollo Organizacional humanista.

En todos estos contextos, Rogers aplica la misma logica: si se crean las condiciones relacionales adecuadas, los grupos tienen capacidad innata para resolver sus conflictos y desarrollarse. Esto es mas una apuesta etica que una receta tecnica.

Limitaciones y criticas: el estudio de Lieberman, Yalom & Miles (1973)

El estudio mas riguroso sobre grupos de encuentro analizo 17 grupos con 206 participantes universitarios y encontro resultados desconcertantes:

- Solo el **38% mostro cambios positivos sostenidos** a los 6 meses
- Un **17% experimento efectos adversos** ("casualties"): deterioro psicologico atribuible al grupo
- Los grupos con lideres muy agresivos o muy caoticos generaron mas dano
- La no-directividad extrema **no protegio** a los participantes vulnerables

Criticas teoricas

- La tendencia actualizante asume un optimismo sobre la naturaleza humana empiricamente discutible
- Subestima el rol del inconsciente y los procesos no verbalizables (cf. Bion)
- La no-directividad puede ser una forma encubierta de poder: el facilitador elige *que no hacer*

Criticas contextuales

- El grupo de encuentro nace en un contexto especifico (California, clase media, anos 60)
- En contextos de alta vulnerabilidad, pobreza o trauma puede ser inadecuado o iatrogeno
- La expresion emocional directa no tiene el mismo significado en todas las culturas

Vigencia actual del enfoque rogeriano en grupos

A pesar de las críticas, el legado de Rogers en la intervención grupal es enorme:

- La **alianza terapeutica grupal** — concepto derivado de Rogers — es hoy uno de los predictores mas robustos del resultado en psicoterapia grupal (Burlingame et al., 2011)
- El **clima grupal** (engagement, contencion, ausencia de hostilidad) tiene bases rogerianas y es medido sistematicamente en investigacion contemporanea
- La enfasis en la **experiencia presente** influyo directamente en Yalom y en enfoques de tercera generacion (ACT grupal, mindfulness grupal)
- En psicologia comunitaria latinoamericana, la horizontalidad y la confianza en los recursos del grupo dialogan directamente con Rogers

No se trata de aplicar a Rogers literalmente. Se trata de reconocer que introdujo una pregunta que sigue siendo central: **¿que tipo de relacion hace posible el cambio en un grupo?**

VIDEO 2 — Dialogo de Carl Rogers con Katy

Video: Dialogo de Carl Rogers con Katy

<https://www.youtube.com/watch?v=wMiimFqKxkc>

Mientras ven, registren individualmente:

- Momentos concretos de las tres actitudes terapeuticas (minuto, gesto o frase)
- Que NO hace Rogers que podria esperarse de otros enfoques
- Que emociones les genera observar esta entrevista

(La actividad de analisis se desarrolla en la siguiente slide)

Actividad: Observacion critica en pares

En parejas — 15 minutos

1. Analisis de las actitudes (5 min)

Compartan los ejemplos concretos que cada uno/a identifico de las tres actitudes. ¿Coincidieron? ¿Vieron cosas distintas?

2. Transposicion al grupo (5 min)

Si esto fuera una sesion grupal en lugar de una sesion individual:

- ¿Que cambiaria en la forma de actuar del facilitador?
- ¿Que gana el proceso al tener otros miembros presentes? ¿Que se complica?
- ¿Como reaccionaria el resto del grupo ante lo que Katy revela?

3. Pregunta critica (5 min)

¿Este estilo terapeutico es adecuado para cualquier persona y contexto? ¿En que contextos chilenos lo ven aplicable, y en cuales no?

Plenaria y cierre

Preguntas para el debate final:

1. ¿En que medida la no-directividad de Rogers es realmente posible? ¿El facilitador puede ser "neutral"?
2. ¿Que tan transferible es esta propuesta a contextos comunitarios latinoamericanos, con sus especificidades culturales y condiciones de desigualdad?
3. ¿Donde ven aplicaciones del ECP en el sistema de salud chileno actual? ¿Y donde lo ven como inadecuado o insuficiente?

Proxima clase: Grupos de Autoayuda, Apoyo Social y Resocializacion. Expositora invitada: Valentina Lastra (UAH).

Lectura previa: Diaz Portillo, I. (2000). *Bases de la terapia de grupo*, Cap. 3.

Referencias

- Burlingame, G. M., McClendon, D. T., & Alonso, J. (2011). Cohesion in group therapy. *Psychotherapy*, 48(1), 34–42.
- Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J. C., & Murphy, D. (2018). Empathy. En J. C. Norcross & M. J. Lambert (Eds.), *Psychotherapy relationships that work* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship. *Psychotherapy*, 38(4), 357–361.
- Lieberman, M. A., Yalom, I. D., & Miles, M. B. (1973). *Encounter groups: First facts*. Basic Books.
- Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy*. Houghton Mifflin.
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person*. Houghton Mifflin.
- Rogers, C. R. (1970). *Carl Rogers on encounter groups*. Harper & Row.
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2005). *The theory and practice of group psychotherapy* (5th ed.). Basic Books.